



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منال سيد محمد حجاج

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : بولاق الدكرور العنوان : ---

رقم البطاقة : 27205290102564 رقم التليفون : 01275266346 تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 29-05-1972 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان الكبد

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان الكبد

خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي ونقل دم ومشتقاته [4951] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال سيد محمد حجاج National ID: 27205290102564	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of liver cancer for Supportive care with blood transfusion
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

متن
سيد محمد حجاج
١٤ ش محمود يوسف فيصل
بولاق النكرور - الجيزة

٢٧٢.٥٢٩.١.٢٥٦٤

KA6332095

٢٠٢٣/٠٦ ٢٧٢.٥٢٩.١.٢٥٦٤
حاصله على بكالوريوس تجارة

انتى
مستلة
متروجة
رمزى عبدالوهاب ابن اهدم العقده
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٦/٢٢

١

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مثال
سيد محمد حجاج
١٤ سن محمد يوسف فيصل
بولاق الدكرور - الجيزة

٢٧٧٢/٠٥/٢٠١١ ٢٧٧٢٠٥٢٩٠١٠٢٥٦٤
KA6332095

٢٠٢٢/٠٦/٢٧ ٢٧٧٢٠٥٢٩٠١٠٢٥٦٤
حاصله على بكالوريوس تجارة
أنثى
رمزى عبدالوهاب إبراهيم العقدة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٦/٢٧



Patient Name : الأسفلاو / منال سيد محمد حجاج	Request No. : 13009948
Patient No. : 27205190102564	Request Date : 25/11/2024
Path No. : 4615/24	Verification Date : 21/12/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 52 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: (Score 1+).
- Ki67: Positive in 20% of tumor cells.
- * Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

- * Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Prof.Gamal Abdelatty
Dr. Rufalda Abdallah

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 29/01/2025 15:32:25

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

PATIENT NAME: MANAL SAYED MOHAMMED HAGAG

GENDER: Female

DATE: 25-Feb-2025 11:44 AM

PATIENT ID: 10125259556

AGE: 52 y

ORDER: 3270777

99MTc-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report:

Active osseous lesions are seen at multiple skull bones, sternum, scattered ribs, scattered vertebrae, scattered pelvic bones, right hip region, right trochanter and less likely proximal left tibia.

Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.

Arthritic changes are seen over both knees.

Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

Positive study for metastatic osseous deposits

Reported By:

Prof. Huda Fathy, Nuclear Medicine Consultant

25-Feb-2025 07:17 PM

PATIENT: MANAL SAYED MOHAMMED HAGAG, 10125259556, Female, 52 y

Report version 1, 25-Feb-2025 07:17 PM

Page 1 of 1





Patient Name: Manal Sayed Mohamed Haggag	Date : 28/12/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 4532/2024	Pat. ID: 94430

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:

- Left breast retrareolar speculated mass measures about 2.3x1.2 cm.
- Multiple enlarged left axillary level I & II lymph nodes , the largest seen at level I and reaches 3.6x2.6 cm.
- Prominent left supraclavicular lymph node reaching 5 mm being fissural based opposite apical segment of left lower lung lobe.
- Bilateral apical reticulations, likely old granulomatous sequel.
- Few bilateral pulmonary nodules reaching 4 mm.
- Prominent subcentimetric mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Presacral lobulated cystic like density lesions with extension through the sacral neural foramina. No related bony destruction.



Patient Name: Manal Sayed Mohamed Haggag	Date : 28/12/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 4532/2024	Pat. ID: 94430

- Right femoral bowel containing hernia.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

- Few vertebral lytic deposits, most sizable at L3 vertebral body.
- Dostolumbar scoliosis with convexity to the left.

Opinion:

- Bilateral pulmonary nodules for follow up.
- No current evidence of hepatic metastatic deposits.
- Few lytic metastatic bony deposits.
- Presacral lobulated cystic structures likely of neurogenic nature ; for post contrast MRI.

Dr. Shaimaa Megahed, MSc

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: منال سيد محمد حجاج

Sex:

3- Medical number:

Female

83251323

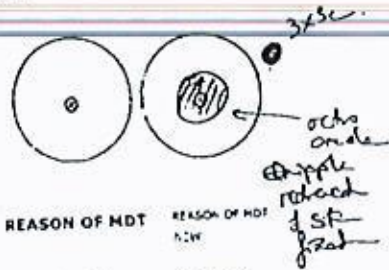
O d Med:

Or Med:

4532-2024

2-ID number:

Patient Age: 52



Family history

Family history

Phone

Phone
01005082463

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2025-03-12

Co morbidity

Co morbidity

Menopausal status

Menopausal status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

It multicentric breast mass+pathological axillary &supracaly

Mets Workup :

bone scan:+ve fro mets osseous deposits

3X IDC Bx COMMENT It gii	ER 8/8 ER COMMENT	PR 7/8 PR COMMENT	Her 2 Neu Her 2 Neu COMMENT -ve	SISH SISH COMMENT	KI67 20
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

T 4B	N 2	M 1 BONE
---------	--------	----------------

Sonomammography

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

NOT OUTCOME & PLAN

START 1ST LINE ET (AT) WITH ZOMETA /3M AFTER DENTAL ASSESSMENT
PALLIATIVE RADIOTHERAPY TO LUMBAR VE D11-L4

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د. محمد عبد الله	RADIOLOGY	RADIOLOGY د. محمد عبد الله
SURGERY	SURGERY د. محمد عبد الله	PATHOLOGY	PATHOLOGY د. محمد عبد الله
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition